

2 - 02- Les cancers du cavum - Pr. Rochdi

(0:00 - 0:16)

On a vu la dernière fois ensemble le concept de la race. Maintenant, on va passer à un autre chapitre qui concerne toujours les voies aériennes supérieures. On verra les concepts du canon.

(0:17 - 0:43)

Le canon, comme vous le savez, c'est la partie plus supérieure des voies aériennes supérieures. Et c'est une zone qui a certaines caractéristiques. C'est-à-dire que si on essaie de la comparer par rapport aux autres organes, c'est un espace qui est quand même profond.

(0:46 - 0:55)

Donc, il n'y a pas d'examen direct du canon. On a besoin d'étudier certains d'entre vous. Ce qui fait qu'il y a un risque, il y a un retard de séquence.

(0:57 - 1:18)

Donc, pour le praticien, pour le médecin qui a toujours le souci de faire un diagnostic précoce, il faudra essayer de rechercher des signes indirects, toujours à la clinique, pour pouvoir poser le diagnostic. Donc, voilà ça. C'est parmi les caractéristiques.

(1:18 - 1:35)

C'est un problème de santé, au moins derrière l'asile. On va le voir, parce que c'est un cancer qui a certaines caractéristiques qui sont des caractéristiques épidémiologiques. Il n'a pas la même fréquence au niveau de tous les pays.

(1:36 - 1:44)

Donc, on va voir que c'est plus fréquent au niveau du Maghreb. Certains ont du Maghreb, en Asie et du Sud-Est. Par contre, c'est le ciel d'alors profond.

(1:46 - 2:01)

Par contre, on l'a dit, c'est comme un bac un petit peu difficile sur le plan clinique. Et, deuxième chose, c'est un espace qui a des rapports cliniques très importants. Donc, imaginez que le clavier, il a des rapports directs avec la base du crâne.

(2:01 - 2:17)

Donc, si c'est facilement, il peut passer à travers la base du crâne, en endocrinien, ou bien avec un rapport ouvert à 32 stages, ou l'oratoire chronique épidémiologique, on avance et on se

resserre, etc. Pour ça, on ne le verra pas. La deuxième particularité, c'est les facteurs de réussite.

(2:18 - 2:31)

Ici, parmi les facteurs qu'on a, c'est surtout un facteur virale. Ce n'est pas comme le grand circulaire à l'axe, ou d'avant, ou d'en haut à l'axe, où on a le clavard et l'alcool. Là, c'est surtout, un facteur virale, c'est l'épidémie d'alcool.

(2:33 - 2:57)

Et, à partir de là, à partir de ces rapports anatomique, on aura une simple hématologie, qui va être très riche, qui va nous faire penser à l'alcool carbone. Alors, un élément aussi qui est important, c'est que, puisqu'on a vu la dernière théorie française de l'arax, les typologies qu'on avait au niveau de l'arax, c'est le carcinome épidermique. Ici, c'est un peu différent.

(2:58 - 3:35)

On a un carcinome qui est indifférencié. Lorsqu'on dit un carcinome indifférencié, en général, pour n'importe quel carcinome indifférencié, nous avons des carcinomes qui sont agressifs, qui donnent plus de métastases, d'accord ? Et donc, la chirurgie, elle joue un rôle très pesant maintenant, et c'est surtout la radiothérapie qui va jouer le rôle crucial concernant la présentation thérapeutique. Alors, sur le point épidémiologique, c'est une pathologie qui, quand même, fréquente au malheur, mais surtout, au niveau de la région orientale.

(3:36 - 4:04)

Alors, sur le point mondial, les épidémiologies sont conservées ici en trois parties. Il y a les zones aoristes, d'accord ? Les zones aoristes, ici en noir, c'est au niveau de l'Asie, et sud-est, là, la fréquence est très importante. La deuxième partie de fréquence intermédiaire, c'est le pourtour méditerranéen, et qui conserve ici le Maroc, c'est-à-dire la Tchézisie, le Maroc et l'Algérie.

(4:04 - 4:36)

Donc, ces zones-là, ils ont une fréquence qui est intermédiaire, et puis, il y a des zones qui sont, une incidence qui est très faible, c'est surtout l'Europe. Voilà, donc, concernant l'âge, remarquez ici qu'on a 2 000 de fréquence. Donc, vous allez voir le concern chez le grand enfant et l'adolescent, et vous allez le voir après, vers les âges un peu avancés, c'est-à-dire à partir de 50 ans.

(4:37 - 4:59)

Donc, il ne faut pas toujours dire que le concern des gros aériens supérieurs, c'est des sujets âgés ou bien adultes, non. Là, il faudra penser toujours au concern du Paroche, c'est-à-dire

l'enfant qui a les signes cliniques, qui est orienté vers une pathologie de cette région. Mais, concernant le sexe, la prédominance, elle est masculine, comme le reste des concerns des gros aériens supérieurs.

(5:01 - 5:21)

Alors, et puis, l'idéologie égale la fréquence, d'accord, et aussi, c'est les facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque, on l'a dit qu'il y a, les facteurs principaux sont les facteurs viraux. Là, le bébé ou l'enfant par virus joue un rôle très important dans la genèse de ce concern.

(5:21 - 5:41)

Alors, ça a été confirmé par la présence d'anticorps ou d'antiviraux soit dans l'océan des patients ou bien au niveau de la tumeur. Alors, ça a été confirmé par la présence d'anticorps et de marmite viraux. D'ailleurs, ça permet les éléments biologiques qu'on peut utiliser pour la surveillance, d'accord, de ce genre de concern.

(5:41 - 5:55)

Les facteurs génétiques aussi sont très importants. Il y a, pour le savoir, il y a des formes familiales de concerns du Paroche. Par contre, les formes familiales existent parce qu'on voit que dans certaines familles, il y a ce concept qui se reflète.

(5:56 - 6:19)

Là, il faut penser aux facteurs génétiques et sans oublier au système HLA. Donc, au Maroc, en général, c'est le HLA-10 et B-18 qui entraîne l'apparition d'anomalies chromosomes. D'autres facteurs d'environnement qui sont présents, mais c'est toujours dans les pays de l'Asie, c'est la consommation des poissons séchés.

(6:19 - 7:03)

Bon, on incrimine aussi au Maroc la consommation de, comment on appelle ça, je ne sais pas de nom, mais en arabe, on appelle ça trillère, pour séparer les facteurs de risque puisqu'ils contiennent des neutrosamines, séparer les facteurs de risque qui peuvent entraîner, mais dans un pourcentage qui reste quand même très limité, l'apparition de ce concept. Alors, il y a d'autres facteurs. Il y a soit l'exposition pour les travailleurs dans l'industrie du caoutchouc en matière plastique, l'exposition pour le format de vie, mais ça, ça reste, la faille d'impact, c'est très important, c'est de retenir le facteur viral et le facteur génétique, ce que j'ai plus à dire.

(7:06 - 7:24)

Quand on y parle, on vient d'enfoncer dans un lieu qui a un risque. Donc ça, c'est une question que j'ai mis à la fin, mais il y a quand même une certaine importance. Il y a passé, même un

adulte qui a passé toute son enfance dans la région, par exemple, de Maroc.

(7:24 - 7:56)

Donc, le fait qu'il a passé son enfance ici, donc, il y a les mêmes risques que les personnes qui vivent dans le pays de l'Aragnac, puisqu'on a vu que c'est un concept qui est fréquent au niveau de la zone-là. Donc, le fait d'avoir passé cette phase d'enfance dans ces régions-là, ça dégarde toujours avec lui le risque qui est imparté à cette région. Voilà, donc ça, c'est les facteurs de risque, surtout le facteur viral et génétique.

(7:56 - 8:19)

Maintenant, on va voir un petit rappel anatomique sur la région du cavernes. Alors, le cavernes, ce qu'on appelle aussi le rhinopharynx ou bien le nasopharynx, c'est un espace aérien qui fait partie des bancs d'aériens supérieurs. Donc, il se suit au poste nasal et se continue en bas par le rhinopharynx.

(8:21 - 8:40)

Alors, il communique avec le poste nasal par les couragnes dans cet espace-là. Là, c'est les couragnes. Ce sont deux orifices qui communiquent au rhinopharynx avec le poste nasal et en bas, ça s'appelle l'isme par un autre nasal.

(8:42 - 8:50)

Donc, les deux sens. Alors, ça, c'est la paroi antérieure, le rhinopharynx. C'est la paroi antérieure constituée aussi par le doigt.

(8:50 - 9:22)

La paroi antérieure, ici, est constituée par le rachis cervical dans sa partie supérieure ainsi que l'os séminal, c'est-à-dire le plémis, ici. Le doigt, il est constitué par le corps de l'os séminal et l'orifice séminal. D'accord ? Alors, ça, c'est le toit du cavant et latéralement, il y a des éléments qui sont très importants.

(9:22 - 9:50)

Donc, latéralement, il n'y a pas d'os, ce sont des éléments musculos pronématiques, car c'est naturel et qui contiennent ce cercle-là. C'est un orifice. Et là, il y a la caisse du tympan où il y a la chaîne du cercle.

(9:51 - 10:35)

Et cette caisse du tympan, elle se prolonge par la tronche de sagir, ce tube postéocartilagineux qui va survivre à ce niveau-là, au niveau de la paroi latérale du rhinocarax. Donc, cet élément qui

est saillant, ici, c'est ce qu'on appelle le torus tuber. c'est ce qu'on appelle la faussette de Rosenmüller, donc ces éléments-là que vous voyez ici, la trempe de Stach avec le thoracis tuber, c'est le cartilage avec les éléments musculaires, derrière il y a une dépression, c'est ce qu'on appelle la faussette de Rosenmüller.

(10:36 - 11:24)

Pourquoi j'insiste sur cette partie de paroi-là ? Un, parce que ça fait partie de l'oreille moyenne, donc la tumeur, il va avoir un retentissement sur l'oreille moyenne, donc on va avoir des signes pathologiques sur vos cliniques, on va comprendre pourquoi un cancer du caverne peut donner des signes pathologiques, c'est expliqué anatomiquement par la présence de la trempe de Stach, ou négocie par le latéral. Deuxième élément qui donne importance à cette paroi, c'est la faussette de Rosenmüller, parce que c'est en général à ce niveau-là qu'on va mettre le cancer du caverne, c'est en général le cancer du caverne qui naît au niveau de cette faussette. Donc on a deux parois latérales qui sont symétriques, d'accord, qui comprennent toutes les deux cette trempe de Stach.

(11:26 - 12:34)

Deuxième élément qui est, donc là c'est un schéma qui montre un petit peu les rapports latéraux, sur cette paroi latérale, donc là c'est une vue qui est postérieure, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder l'hémopharynx d'en arrière, on a enlevé cette paroi postérieure et on est en train de regarder par là, voilà ce qu'on voit, on va regarder ici, donc vous avez tous ces éléments-là, donc ici il y a la trempe de Stach qui n'est pas schématisée, mais vous voyez qu'il y a des éléments nerveux qui passent, donc vous voyez ici la fosse infratemporale, ça c'est l'osso-entorale, et puis vous avez tout ce qui est au-dessus, ce qu'on appelle la fosse infratemporale, qui comporte les éléments du nerf régulier, c'est le nerf mandibulaire, et vous avez les muscles masticateurs. Donc, à partir de là, c'est ce qu'on comprend. Lorsqu'on a une tumeur au niveau du capot, on peut avoir l'extension vers cette zone-là, et on va voir que c'est des signes qui vont potentielles sur la mastication, par exemple on va voir un trismus avec une limitation de l'ouverture de la bouche, ou bien on peut avoir même des couleurs faciales.

(12:35 - 13:06)

Donc là, ça montre un petit peu des rapports à notre but latéral. Vers le haut, vous avez la base du crâne, en avant ça c'est les poings et les orifices comme j'ai parlé, qui sont séparés par le roman au centre, et vers le bas, vous avez le voile du palais avec la luette, cette zone-là, à ce niveau-là, c'est pas le rhinoparaxe, c'est l'oroparaxe. Donc vous avez le rhinoparaxe, l'oroparaxe, et au-dessous c'est l'oroparaxe ici, avec l'oroparaxe latéralement.

(13:06 - 13:27)

D'accord ? Donc là, on a une lecture des rapports anatomiques. Alors un élément que je ne dois

pas oublier, c'est concernant les rapports supérieurs. Ici on a dit les rapports supérieurs se font avec le cordon sphénique, avec le semisphénique là, ici il y a un élément, ça s'appelle la scène sur cycle.

(13:27 - 13:45)

Qu'est-ce qu'il y a dans la scène sur cycle ? Là, l'hépophyse. Donc là on l'hépophyse, l'aisseau se trouve là, et latéralement, vous avez le parc de la traction ischiave en bleu. Qu'est-ce qui traverse la traction ischiave en bleu ? Les nerfs oculomoteurs.

(13:46 - 14:57)

D'accord ? Les nerfs oculomoteurs, donc on a les nerfs oculomoteurs, donc la tubeur du canon, il peut facilement s'étendre, s'il arrive à traverser l'os, il peut s'étendre jusqu'à l'oeuf, et avoir ici une neurologie qui se forme là-dedans, c'est des nerfs crâniens. Là vous avez une vue endoscopique du larynx, d'accord ? Donc on a ici une vue endoscopique ici, donc là on est en train de voir, à travers le nasale, le rhinoparynx, vous avez ici la partie médiale, où il y a le poison nasal, ça c'est la coine, ça c'est le doigt du cabot, et latéralement on voit ce doryphysta, d'accord ? Le doryphysta c'est la tronche de stache, le doryphyste du verre comme on l'a vu, et derrière il y a la rosette de prosélylgène. Et tout ça c'est recouvert par une muqueuse de type respiratoire, c'est très important.

(14:58 - 16:01)

Même chose ici, donc on est en train de voir à travers le poison nasal, là on a le poison nasal, là c'est la coine et au fond on voit le rhinoparynx. Alors remarquez une chose, ce que vous voyez ici au fond, donc là vous voyez, ces éléments là, qui font ça, ils sont brillants, d'accord ? On les appelle les végétations adéluïdes, vous entendez parler des végétations adéluïdes, c'est un tissu l'influide, alors pourquoi je suis en train de vous parler de ça, parce que le rhinoparynx c'est un organe qui est très riche, un organe, qui fait partie de ce qu'on appelle l'anneau de Valdээр. Si je prends ce schéma ici, donc l'anneau de Valdээр, il comprend tout le tissu d'un fluide au niveau du rhinoparynx, au niveau des amygdales, et au niveau des organes influides, au niveau de la place de l'angle, on appelle ça l'anneau de Valdээр.

(16:01 - 16:37)

Donc les organes influides à ce niveau là, ils ont une taille comme un petit peu importante quand on se touche à l'enfant, donc ils peuvent parfois même être aussi agilités par le trophique, et avoir un peu d'une restriction respiratoire. Donc la présence de ces organes d'influides qu'on appelle l'amygdale pharyngée est importante à connaître. Pourquoi ? Parce que si vous faites examen du rhinoparynx, par exemple par un hôpital, vous allez voir ce tissu d'un flou illicite.

(16:37 - 18:30)

Pour ne pas le confondre avec l'humain, avec un cancer, pour savoir où ça existe de façon normale, c'est vrai qu'il est plus gros chez le recentre et l'enfant, mais une fois l'enfant ait dépassé l'âge de 5 ans, 6 ans, ça, ça va être aussi une régression, une involution, avec une diminution de taille, parfois une persistance, un petit repas, ou bien presque une disparition complète. D'accord ? On ne comprendra pas le confondre avec une tumeur, souvent en général elles sont bourgenantes, fulcérées et facilement saignantes. Alors, dernier élément dans le rapport à l'anthropique, parce qu'on a vu maintenant le siège du rhinopharynx avec ses patois et ses éléments anisométriques qui sont autour, l'élément aussi important, c'est le drainage d'infection.

On a dit que c'est une zone qui est riche en organes d'influides, donc il va y avoir un drainage qui est très important. Et ça va avoir un racontissement sur l'évolution du cancer du canard. On aura un cancer qui va être très rapide, qui va donner beaucoup de castase dans le canard.

D'ailleurs, c'est parmi les signes d'appel. C'est-à-dire, avant le diagnostic, donc le mal arrive déjà avec une grosse adénopathie, c'est radical. Alors, le drainage d'anthropie il se fait au niveau de la chaîne, il se fait au niveau de la chaîne jugulocarotidienne, c'est des groupes qu'on a vu la dernière fois, le 2, le 3, le 4, et il se fait aussi en extérieur, au niveau de la chaîne spinal.

Voilà, donc il faut retenir jusqu'au niveau du ganglion sur la vécula. C'est les deux éléments qu'il faudra retenir concernant le drainage d'infatig. Voilà, ici, c'est le schéma des ganglions avec la chaîne jugulocarotidienne, ici, et vous avez les ganglions jugulocarotidien, supérieur, moyen et inférieur.

(18:33 - 19:48)

Voilà, donc ça c'est concernant, on peut le rappeler, l'anatomie qui est très important. Maintenant, sur le plan de l'anatomie pathologique, macroscopiquement, c'est un tubeur qui va être bourgelant ou sévère, et sur le plan microscopique, on aura un type histologique qui va concerner plus de 70%, c'est le carcinome indifférencié, qui s'y transforme par un gène, qu'on va faire en abrogation le UCLT, carcinome indifférencié, de type nasopharyngeal. On peut avoir d'autres carcinomes, carcinome indifférencié, surtout chez les personnes âgées, qui a un pronostic un petit peu différent par rapport au premier.

Sinon, on peut avoir d'autres, on peut avoir des sarcomes, des lymomes, des aminocarcinomes, et l'immunocytome, grâce au marquage qu'on peut faire, permet de confirmer le diagnostic et d'éliminer les diagnostics différenciés. On peut retenir ici le UCLT comme gène principal et c'est lui qu'on va traiter aujourd'hui. L'extension de l'âme, on l'a, on a un carcinome un peu anatomique, donc on peut avoir une extension qui peut se faire antérieure, qui peut être noire, sinon on fait une obstruction nasale, soit irrélaterale, soit illatérale.

(19:49 - 20:55)

On peut avoir une extension antérieure, remarquez ici, ce qu'il y a derrière, on a dit que la part postérieure, c'est tout, le racisme cervicale, c'est l'espace rétrofaringé, parce que dans la muqueuse, il y a les muscles prévertébraux, alors entre la muqueuse et les muscles prévertébraux, on a l'espace rétrofaringé. C'est derrière le rhétorique on peut avoir des muscles prévertébraux, sinon on a une extension latérale, la trompe positive, l'aération de l'oreille moyenne et surtout l'équilibration de la pression. Donc si la trompe de Eustache ne fonctionne pas correctement, l'oreille moyenne ne va pas avoir une pression équilibrée parce que normalement pour avoir la transmission du sang de façon optimale, idéale, il faut avoir la même pression au niveau du visage extérieur qu'au niveau de l'oreille moyenne.

(20:56 - 21:12)

Donc si la trompe de Eustache est obstruée, on va avoir une dépression au niveau de l'oreille moyenne et on aura même une sécrétion. Il y aura des sérosités qui vont apparaître au niveau de l'oreille moyenne. On aura une hypopression et on aura une sécrétion.

(21:13 - 21:47)

C'est pour ça que parmi les signes idylliques dans ce concept, il y a des signes séromiqueuses qui sont caractérisés par la présence de liquides dans les cochons au niveau de l'oreille moyenne. Donc trompe de Eustache, c'est les touchés, soit qu'il va être obstrué, ou bien les muscles qui jouent un rôle dans la fonction de la trompe de Eustache, ce qu'on appelle les muscles éleveurs des voies du palais, les muscles transverses des voies du palais, c'est les muscles principaux dans la fonction de la trompe de Eustache. Lorsqu'ils sont touchés, ça va reprétir sur la fonction de la trompe.

(21:47 - 22:21)

Sinon, on peut avoir une extension très importante de la masse, c'est l'extension de la fosse infraponcrale, avec un tas de muscles masticateurs et du branchement de l'air dans les épaules. Sinon, on peut avoir une extension vers l'oropharyngéal et que le bon B, au niveau de l'oropharyngéal est touché par la région pramégingale. Alors, concernant les métastases convulsionnaires, ils sont très fréquents puisqu'on a dit que c'est un cancer qui est très mal confit et le rhéopharyngéal a un dréamme, c'est une pratique très importante.

(22:22 - 22:46)

Donc, ils se font souvent de façon bilatérale. Les métastases à distance, ils se font surtout au niveau des points. Une chose qu'il faut savoir, dans le carcinome indifférencié, c'est un tumeur qui est agressif, avec une évolution qui est rapide et qui donne des métastases convulsionnaires, dans le cas du carcinome pythagore, qui donne beaucoup, de façon beaucoup plus fréquente, des carcinomes à distance.

(22:47 - 23:28)

Parce que les cellules sont indifférenciées, ils ne ressemblent pas à la cellule mère, donc ils peuvent facilement se détacher dans la circulation sanguine et aller se fixer au niveau d'autres organes, tels les centuros et le bon B. Alors, quel sens est-il qu'on a dit que c'est un organe qui est trop grand ? C'est un organe, le cas où on ne peut pas examiner facilement à la clinique. Donc, il faudra rechercher des signes indirects qui vont nous orienter vers la date de cet espace. En général, on a quatre syndromes.

(23:28 - 23:55)

Il y a un syndrome convulsionnaire, autologique, un syndrome neurologique et un syndrome biologique, qui peut être associé de façon variable, parfois même présent, d'emblée. Le syndrome convulsionnaire, c'est très facile, c'est une adénopathie qui est une carotidienne haute, l'être homo-végulaire, et sous-masculinienne, les gouttes gastriques, l'esprit nerve supérieur. Donc, on génère à ces patients comment ils arrivent.

(23:55 - 24:53)

Là, il y a une adénopathie inflammatoire, qui est mobile, plus ou moins sensible, douloureuse. Là, l'adénopathie n'est pas douloureuse, mais elle est grosse, elle est fixée, et elle est évolutive. C'est-à-dire que le patient, il arrive, il a une adénopathie depuis presque 40 jours, et il a remarqué que l'adénopathie est grossiste, et il arrive avec même une masse qui est déjà fixée dessus.

C'est un syndrome masculinien, fixé dans le plan vertical, parfois même fixation, sous le panneau du corps. Donc, l'adénopathie qui est quand même dure, qui est fixée, qui est haute, en général, dans les adénopathies formes débutantes, l'adénopathie qui est haute et qui est un petit peu postérieure. Pourquoi ? Parce que le drain de l'adénopathie qui se fait au niveau des gros c'est surtout supérieur, et vers la région C. Donc on a une adénopathie qui est haute, supérieure, et un petit peu postérieure.

(24:55 - 25:20)

Sinon, si la maladie évolue sans traitement, on va avoir des adénopathies qui sont grosses, qui descendent parfois, mais qui sont disponibles. En général, on va avoir l'adénopathie qui vient de passer en stade de début, c'est une adénopathie qui est haute, supérieure et postérieure, et qui est déjà bilatérale, gombée. Pourquoi ? Parce que le drain de l'adénopathie qui se fait de façon croisée, bilatérale.

(25:21 - 25:32)

Deuxième syndrome, c'est le syndrome ontologique. Donc là, c'est en rapport avec l'atteinte de

l'enfant de Stachan. Ça peut partir du simple sensation d'oreilles bouchées.

(25:32 - 26:07)

Autalgie vraiment minime, c'est pas l'autalgie d'autisme moyen et aigu que ça dit très importante. Il ne faut pas s'attendre à ce que le patient vous raconte qu'il a très mal pour se mettre en alarme. La présence d'une sensation de blessure d'oreille une fois apposée, autalgie minime, mais de façon chronique, constante, et répétée, associée éventuellement à l'adénopathie, là il faudra s'alarmer et proposer l'indication d'un examen endoscopique de l'adénopathie.

(26:10 - 26:40)

Le syndrome rhénologique, là, c'est l'évolution de la tumeur qui va obstruer les oreilles. Le patient peut avoir une obstruction nasale, une bilatérale ou bilatérale, mais sa caractéristique pour pouvoir la différencier, par exemple entre la tumeur et une réelle allergie, une sinusite, c'est que l'obstruction est constante. Dans l'allergie, l'obstruction est intermittente, elle est abassue parfois à droite, parfois à gauche, avec une réelle oreille claire.

(26:40 - 27:23)

Là, c'est une obstruction nasale qui est présente, qui est constante et qui est évolutive, d'abord bilatérale et après devient bilatérale, associée éventuellement à des épistaxis. Ce n'est pas l'épistaxis très importante, c'est ce qui est mis dans ces pressions de réelle oreille claire associée à des gouttes de sang pour bien défiler le sang associée à une rhinolalie fermée. Alors, le mot rhinolalie, c'est une biologie, la rhinolalie, c'est une modification de la voie qui est en rapport avec des fausses nasales ou bien une problématique de rhinoparthe.

(27:23 - 27:49)

Il y a deux types de rhinolalie. Soit c'est une rhinolalie qui est fermée, c'est-à-dire que la modification de la voie est en rapport avec une obstruction nasale, c'est ce qu'on a ici, on a une tumeur qui va obstruer les poils, qui va obstruer les fausses nasales, donc on aura une rhinolalie fermée. Quand on a, par exemple, une zone enrhumée, quand on a la muqueuse du nez qui est congestive, notre voie est modifiée.

(27:49 - 28:25)

C'est ce qu'on appelle la rhinolalie fermée, donc c'est une modification de la voie par l'obstruction des fausses nasales. Associe, probablement, c'est ce qu'il y a ici. La rhinolalie fermée, c'est que le passage aérien au niveau des fausses nasales par exemple du parent, il est normal, il n'y a pas d'obstruction, mais il y a une modification de la voie.

Ça, on le voit par exemple dans l'insuffisance vellaire ou bien dans les frontes vellaires. Si vous vous rappelez des frontes vellaires, je ne sais pas si vous avez fait ça en pédiatrie, en chirurgie

apprentie. Ça, c'est le voile du palais.

(28:26 - 28:39)

Vous voyez ici, ça, c'est le voile du palais. On a ici une vie postérieure, une pharynx, une pharynx, ça, c'est le voile du palais. Alors, chez certains enfants, de façon angélique, assez malformative, on a une fente.

(28:41 - 28:51)

D'accord ? On a un voile du palais qui est espantillé. Il n'y a pas d'union entre les deux voiles. Parfois, ça peut s'étendre jusqu'à avoir une fente labiale associée.

(28:51 - 29:03)

Ça, ça s'appelle la fente labio-palatine. Il y a la labio-alto-palatine. C'est la fente qui part de la lèvre à travers le palais osseux et le palais.

(29:03 - 29:45)

Alors, lorsqu'on a une fente vellaire et une fente palatine ici, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est que lorsque le patient parle, il y a une fuite d'air qui se fait de la pharynx vers le rhinopharynx parce que normalement, pour émettre certains consommés, certains phénomènes, il faut que le voile ferme le rhinopharynx en bas pour que l'air passe complètement par la cavité du cap. Alors, lorsqu'on a une fente, le voile ne ferme pas, on parle d'une incompétence du voile qui n'est pas une compétence de lèvre. Ce qui fait l'air, il passe, il y a une fuite d'air qui passe contre le rhinopharynx et ça entraîne une modification de la voie.

(29:45 - 30:12)

C'est ce qu'on appelle la rhinoradie ouverte. Ici, dans cette pathologie du cancer du cap, on parle de rhinoradie fermée. Alors, le syndrome neurologique, c'est des céphalées urbaines.

Pourquoi des céphalées ? C'est souvent en rapport avec une atteinte osseuse au niveau de la base du cap. Il y a même parfois une atteinte qui mélange par extension à travers la base. Il y a une extension carrément endocrinienne.

(30:13 - 30:47)

Des nébratophagia. Pourquoi des nébratophagia ? Oui ? Atteinte de ? Quels très jumeaux ici ? Qui va toucher ? Le ? Mondibulaire. Pourquoi le mondibulaire ? Voilà, donc si on a des nébratophagia de basse, ça veut dire une atteinte du nerf mondibulaire.

(30:47 - 31:07)

Pas par extension du concentrat temporal. Mais si vous avez des nébratophagia hautes, au niveau frontal ou contemporain, par quelle mécanisme ? Non, par la sinusie. La sinusie, c'est pas des nébratophagia.

(31:08 - 31:20)

La douleur de la sinusie, c'est pas des nébratophagia. Les nébratophagia qui touchent le territoire facial supérieur, c'est des nébratophagia 5.1. C'est la première branle. Et là, très jumeau.

(31:21 - 31:40)

Pourquoi il va se toucher ici ? A travers la basse du crâne. Et latéralement, ça va toucher le sinus caroténeux. Donc on a dit que latéralement, par rapport à la sinusie, il y a le sinus caroténeux.

(31:40 - 32:24)

On passe des lèvres plus que l'on en a deux, avec des branches très jumeaux. Donc on peut avoir des nébratophagia surto ou dans le territoire supérieur ou carrément une paralysie pour que l'on l'entrisse. C'est-à-dire qu'on voit une patient avec un problème, soit un stramisme interne, un stramisme externe, etc.

C'est tout par partage soit du 6 ou bien du 3. Parfois, on peut avoir un trismus. Un trismus, c'est une limitation de l'ouverture de la bouche et d'accord. Par quelle mécanisme ? Par contracture musculaire.

(32:25 - 32:41)

C'est pas illimitable, parce qu'on peut avoir une limitation de l'ouverture de la bouche, par un problème d'onkylose, de l'articulation tampon, des lèvres. Là, c'est un trismus avec une articulation qui est intacte par contracture des muscles masticateurs. C'est comme un bus sur le schéma précédent.

(32:41 - 32:58)

Les muscles masticateurs, c'est assez moulant. Donc, le pterygmien médial, le pterygmien lateral, lorsqu'ils vont être touchés, on vient par atteinte du lèvre. Pourquoi ce lèvre là ? Parce que lui, un mandibulaire, c'est lui qui énerve les muscles masticateurs.

(32:58 - 33:36)

Donc, si la tumeur touche le lèvre, touche le muscle, on peut avoir une contracture d'aplexe et on va avoir une limitation de l'ouverture de l'aplexe. Donc ça, c'est un trismus. Voilà, donc ces 4 syndromes, il faut les connaître.

C'est un syndrome ganglionnaire, autologique, rhinologique et rhinologique. Il faut les connaître, il

faut les garder à l'esprit, d'accord ? Chez un grand enfant, chez un adolescent, un adulte, à partir de l'âge de 40 ans, 50 ans, il faut penser à une pathologie rhinologique. Avant, on ne parlait pas d'hyalurisme, paralysie, peut-être que téléconduite.

(33:36 - 33:54)

Là, le monsieur le patient vous dit que c'est après un traumatisme, en marchant sur le trottoir, l'une main, et après, il n'y a pas de sentiment. La présence d'une rhinologie en pratique, ce n'est pas en rapport avec le traumatisme. D'accord ? La présence d'un outil à l'examen clinique, ce n'est pas un traumatisme.

(33:54 - 34:35)

La présence d'une obstruction nasale, avec des pesticides minimes ou sans pesticides, d'accord ? Il faut ne pas être à l'aise sans avoir examiné le rhinoparse. Alors, devant ces cliniques, devant ces syndromes, il faudra qu'on fasse ce qu'on appelle une asymptotomie. D'accord ? C'est un fibroscope qu'on fait introduire par les cosmozales, avec une anesthésie locale ou parfois sans anesthésie chez les personnes opérantes.

On va rentrer par monnaie, on va faire rentrer le fibroscope et ça va nous donner directement l'image en traversant les cosmozales. Voilà. On voit toute la cosmozale qui a été décorée.

(34:36 - 34:53)

Et on va passer à travers les cônes pour être directement au niveau du rhinoparse. Un rhinoparse normal, c'est un rhinoparse normal d'un adulte. Pourquoi un adulte ? Parce que la zone où on devrait avoir des végétations anémiques, là elles sont très absentes.

(34:53 - 35:18)

Il y a une petite rupture qui est normale. Donc là, il n'y en a pas d'eux. Tu viens de visiter.

On voit le rhinoparse avec sa muqueuse saine, secrètement, c'est propre. On voit ici les deux doses du verre, d'accord ? C'est vrai que je vais mettre un autre schéma, le rhinoparex, avec d'autres vidéos. Donc voilà.

(35:19 - 36:20)

Donc là c'est un rhinoparex normal, avec un petit onycat que j'ai placé en milieu vide. Vous avez le torus tuber. Là, vous avez la trompe de sache qui s'isole là.

Il va y avoir le tumeur. Lorsqu'il y a la présence du tumeur, voilà ce qu'on va voir. On va voir le tumeur qui est... qui est bourgeonnante, hein, qui comble toute la poire.

Vous avez ici la colonne mondiale, la paroi latérale est placée là avec le vent bien inférieur, le

plancher est placé là, et là vous avez le tumeur qui est bourgeonnant, très vascularisé, relativement, pas trop vascularisé, mais qui est dans une des zones de saignement. Pour passer de l'avant, parce qu'en général, la vascularisation dans les cancers est anarchique, parce qu'il y a de temps en temps des nécroses, des ruptures vasculaires, des tumeurs supérieures et des tuyaux qui descendent facilement. Si l'examineur essaie de la toucher avec un aspirateur ou un instrument, ça va s'éteindre rapidement.

(36:21 - 45:43)

Donc pas un sédiment qui va être tout voyant, mais un sédiment qui va être unique, qui va s'arrêter rapidement. Mais c'est ainsi qu'il est important. Donc là, l'asthmophilosophie grasse, l'asthmophilosophie grasse, en plus bien permet rapidement de pouvoir examiner, de pouvoir voir exactement le siège de l'asthme.

Est-ce qu'il est sous-estimé ? Est-ce qu'il est bien limité ? Ou bien, comme le cas d'ici, il est très étendu en avant ? Et après, il faudra prévoir un bilan par ligne, qu'on va faire par la suite. Bon, il y a un autre examen qu'on peut faire, mais il est un petit peu difficile, ça demande une coopération de la part du patient, c'est ce qu'on appelle la rhinoscopie postérieure. C'est-à-dire que le médecin se met devant le patient, il va mettre une lumière frontale, il va introduire dans la cavité buccale du malade un miroir, c'est comme le miroir qu'on a vu pendant le souci indirect, mais là il va être inversé, parce que le référent c'est l'état de l'eau, donc on va introduire le miroir par la cavité buccale, on va tirer un petit peu sur la langue et ça va nous donner l'image inversée du perron, vous avez la paroi chaude, vous avez la cloison hasarde du miroir, l'échoïne, et latéralement, les parois latérales du miroir, jusqu'à là, il n'y a pas de timbre, mais le réflexisme, l'oseilleux, quand on fait ces examens, le perron général de pouvoir vient l'explorer, actuellement c'est un examen qui est délaissé au profit d'un instrument scientifique qui est très facile et très efficace.

Alors ça c'est l'examen qu'on va faire en premier. Toujours dans le cadre de l'examen ORF, devant les sciences ontologiques ou en l'absence de sciences ontologiques, on peut tomber sur ce qu'on appelle les motifs seromucueux, qui est secondaire à atteinte de grandes sachets. Un motif seromucueux, il est défini par trois, c'est une inflammation chronique de la muqueuse et de l'oreille moyenne associée à un écoulement, c'est-à-dire qu'on va avoir une inflammation avec la présence d'un liquide, et si l'inflammation est secondaire à l'obstruction de la forme de sachets, ça va donner un aspect comme ça, vous avez normalement au niveau de l'oreille moyenne, il n'y a pas de liquide, c'est d'accord, il n'y a ni point de l'air.

Dans la caisse du tapot, il n'y a pas de liquide. Après dans la médecine, c'est anormal. D'ailleurs la présence de liquide, on l'entend aussi sur l'audition en train de filer, il pourra causer.

Alors là on remarque qu'il y a, qu'est-ce qu'on voit ici ? Des bulles d'air. Qu'est-ce qu'on doit avoir pour avoir des bulles d'air ? Ça c'est une endoscopie, on est en train de faire l'endoscopie, on

met des ambulances par endoscope en évoquant l'endormissement. Qu'est-ce qu'on doit avoir des bulles d'air pour l'endormir ? On voit qu'il y a de l'air, donc on ne va pas avoir de bulles d'air.

Lorsqu'il y a des bulles d'air, ici on parle de niveau de l'endormir. Vous avez du liquide et de l'air, sur du liquide et de l'air, ça c'est du niveau de l'endormir. Donc on a présente de ce que ceci témoigne.

Il n'y a pas de perforation perforative, il n'y a pas de rougeur d'inflammation très importante qui aurait ouvert l'antidroïde. Là notre implant n'est pas perforé, il est un peu bas, il continue, mais il laisse voir du liquide avec de l'air à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle du liquide d'endormir.

Ça c'est l'antidroïde. Lorsqu'il est unilatéral, il faut penser à une tumeur du cavernes. Ça c'est un réflexe, il faut garder toujours une position rugueuse unilatérale et garder en milieu, éliminer la présence d'une tumeur du cavernes.

Donc là c'est la même chose, sauf que ici c'est un peu différent, c'est une position rugueuse, mais la différence c'est qu'il y a du liquide d'endormir toute la caisse, il n'y a plus d'air, là il y a encore de l'air, et ici c'est tout le liquide qui vient. Mais ça correspond à une anxiété rugueuse. Voilà, donc on a examiné le dos nasal et le pharynx, il y en a examiné les deux oreilles pour voir s'il y a plus la présence d'une anxiété rugueuse.

L'examen de l'oropharynx nous permet de voir est-ce que la tumeur est ombre au niveau de l'oropharynx, est-ce qu'elle refoule le pilier, il y a des piliers postérieurs ou il y a le voile du palais en avant. Et on terminera l'examen de l'oreille par l'examen des aires ganglionnaires. Bon, essayez de voir la présence des adénopathies, leur siège, comme on l'a dit, qui est orienté vers le cavernes, des ganglions ou bien adénopathies qui sont hautes et postérieures.

Et puisque ces adénopathies sont d'origine maligne, en général elles sont relimitées, fixées. Non, elles ne sont pas douloureuses, bien très peu sensibles. Il faut voir est-ce qu'elles sont bilatérales, quels sont les groupes qui sont touchés, qu'est-ce que ça fait de la région supraculaire qui est dévoilée d'une maladie qui est très avancée.

Et puis il y a l'examen neurologique. Donc pour rechercher sur l'atteinte du nerf au kilomoteur 6, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là, le kilomoteur 6 ? Un malade qui a une atteinte du nerf au kilomoteur 6, le nerf au kilomoteur externe du roulet. On va donner un strabisme.

Qu'est-ce qu'un strabisme ? Convergent. Convergent, très bien. Un strabisme interne.

Pourquoi ? Voilà, parce qu'on appelle ça le nerf au kilomoteur externe. C'est lui qui entrave la rotation bleue de la partie externe. Puisqu'il est touché en bleu, le chemin inverse, la rotation inverse en bleu, va s'orienter en dedans.

C'est un strabisme convergent. Oubliez l'atteinte du 5, donc on va explorer le territoire du 5, 5-1, 5-2, 5-3, toujours examiné de façon comparative, avec les ongles, en demandant au patient est-

(45:43 - 46:12)

Dans la paralysie faciale, le contraire. La face est attirée vers le côté simple. Dans la langue, lorsqu'on fait la protraction, pas la rétraction, la rétraction c'est l'inverse, lorsqu'on fait la protraction, on a une déviation vers le côté atteint.

(46:17 - 47:03)

(47:04 - 47:33)

(47:33 - 48:06)

Donc on va faire une IRM en premier, associée éventuellement à un scanner. L'IRM nous permet d'explorer les parties volantes, et le scanner nous permet d'en donner une idée sur la glosse que nous avons sur le crâne, ce qui est touché au crâne. L'IRM va nous montrer le siège de la

tumeur, son extension au niveau des parois d'intervalle, donc ça, c'est l'IRM au niveau du rhinoparaxe, il est centré sur le rhinoparaxe, il est en coupe axiale, horizontale.

(48:07 - 48:38)

Donc, on va mettre ici la glosse nasale, les sinus maxillaires, là c'est la partie courte, inférieure à droite, et ici vous avez le rhinoparaxe. Vous voyez qu'il y a un hypersignal qui est hétérogène, une magnémité qui est déjà étendue latéralement au niveau de la partie interne de la poste ultracorporelle. Donc, devant la présence de ces tumeurs, il faudra passer au scanner.

(48:39 - 49:07)

Le scanner nous permet de voir les parties volantes aussi, puis de passer en haut. C'est-à-dire moins évident, mais c'est à dire qu'il faut voir ce qu'il se passe au niveau de la glosse. Par exemple, ici, c'est un scanner au niveau de la face qui passe par le sinus éthmoïdale, la glosse en nasale, la cellule surcique, le lobe ventral, droit et gauche, et la face cérébrale postérieure.

(49:08 - 49:27)

Donc, on a la cellule surcique ici, et on a un comblement au niveau du sinus éthmoïdale, c'est la partie postérieure, et on a des lisses osseuses par endroits. Donc, ces lisses osseuses, on ne pourra pas les voir à l'IRM. L'IRM n'explore pas de glosse.

(49:27 - 49:50)

En général, on fait les deux. Il y a l'IRM et le scanner. L'IRM, il faut voir la tumeur, sa texture et son extension latéralement, au niveau de la poste ultracorporelle, parce que latéralement, comme on l'a dit, il n'y a pas de glosse, c'est un embossage, mais le reste, c'est les muscles de la poste intratemporale et les muscles relais.

(49:51 - 50:37)

D'accord ? Par contre, pour voir la poste ultracorporelle vers le haut, le registre cervicale avec l'arbre antérieur de l'osseuse cérébrale, c'est surtout grâce au scanner. Voilà, ces deux examens permettent de localiser exactement la tumeur, voir son siège, et rechercher les signes d'agressivité. C'est-à-dire qu'il y a une liste osseuse, puisque la tumeur est mal limitée, puisqu'une infiltration à travers la base du crâne vers l'endocrine, avec la présence d'une ostéolyse, ce sont les signes d'agressivité qui témoignent du caractère éventuellement cancéreux de cette maladie.

(50:38 - 51:23)

Il faut aborder ça, il faudra faire un bilan biologique pour voir s'il n'y a pas de problème des moustaches, par exemple une thrombophilie, un taux de trop trombine qui est bas, un

arrangement des tendres, de saignements, qui peuvent nous pousser à avoir plus de précautions, parce que juste après il faudra faire une rhinocartoscopie, c'est l'équivalent d'une nasophyloscopie, mais avec un endoscopie rigide, pour pouvoir faire une biopsie. Si vous entendez parler de rhinocartoscopie, c'est une sorte de nasophyloscopie, mais pas avec un fibroscope, mais avec un endoscopie rigide, tout simplement. La différence est au niveau de l'instrument, mais c'est le même exemple.

(51:24 - 51:53)

La nasophyloscopie se fait en consultation, puisque c'est un instrument qui souffre, on peut l'examiner avec un enfant, une femme, un adulte, etc. La rhinocartoscopie, c'est un endoscopie rigide, donc ça demande en général une anesthésie locale, voire générale, chez certaines personnes, ou bien chez les enfants. Dans l'endoscopie rigide, ça permet de faire en même temps aspirer, faire des biopsies multiples, pour adresser des échantillons.

(51:54 - 52:55)

Très rapidement, chez nos amis endocrinologistes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'il faudra mettre sur le contenu l'aspirant endoscopique, L'aspirant endoscopique, on doute sur le caractère malin, il ne faut pas dire qu'il n'est pas un tumeur, parce qu'il a une présence, des tumeurs bourgeoises, par exemple, plus serrées, scellantes, avec des symptômes agressifs, virus canaires, carotidiennes, avec une atteinte pathologique, comme ça. Le médecin endocrinologiste, il va savoir qu'il est devant un tumeur agressif, ce n'est pas un tumeur malin, et s'il a des difficultés au diagnostic, la clinique va l'aider, pour pouvoir confirmer que ça n'est pas un diagnostic, et ne pas le demander à refaire une deuxième biopsie. Donc, l'exemple qu'on peut demander, c'est la sérologie, ça sert surtout pour la surveillance, la recherche d'anticorps, anti-épinébrate virus, les IGA, qui sont utilisées par certains instituts, surtout pour le suivi des patients, voir leurs réponses, et surtout guetter les résidus.

(52:56 - 53:10)

Donc ça, les images qu'on a tenues. Alors, une fois qu'on a confirmé le diagnostic, il faudra faire le bilan d'expansion. Le bilan d'expansion pour analyser les tumeurs qui sont très lymphophiles, et qui donnent des métastases en distance.

(53:10 - 54:23)

Bon, le reste des carcinomes, des tumeurs, est différentiel. Donc on fera un scanner cérébrothoracique, de façon systématique, pour rechercher les anticorps systématiques, en même temps on voit s'il y a des métastases du niveau pulmonaire, les pochements fleurales, intestinales, l'hypographie incontournable. Parfois, on peut demander des psychas, ou même une scientifique graphique, au secours.

Et après, il faudra faire un bilan très thérapeutique. Alors, pourquoi un bilan très thérapeutique ? Parce que, comme on l'a dit, le traitement de ces carcinomes est basé surtout sur la radiochimie thérapeutique de la chirurgie. Donc il faudra vérifier le patient pour savoir s'il va pouvoir supporter la chirurgie ou la radiothérapie, en évaluant l'activité cardiaque, l'adrénaline, l'hépatite.

D'abord, voir est-ce qu'il y a d'autres pathologies associées à le diabète ou l'hypertension. Il y a d'autres pathologies qu'il faudra corriger pour le préparer. Alors, quelles sont les autres pathologies qu'il peut, ou même qu'il faudra, éliminer devant certains aspects cliniques ? En premier lieu, c'est l'hypertrophie des végétations anémiques.

(54:25 - 54:41)

Qui dit végétation anémique, c'est un problème qui se passe au niveau des rhéopharynxes, en rapport avec les organes lymphoïdes. On a dit que les rhéopharynxes, c'est un espace qui est riche en organes lymphoïdes. C'est une partie de ce qu'on appelle l'alent de Val d'Eyre.

(54:42 - 55:14)

La présence de plusieurs folies de lymphoïdes, c'est-à-dire cette zone est caractérisée par l'hypertrophie de ces végétations qui vont augmenter de taille au cours de l'enfance, c'est-à-dire après la première année, ces végétations anémiques vont augmenter de taille. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de l'expérience naturelle du nourissant. Ça vient de l'enfant.

(55:16 - 55:29)

Ça c'est le rhéopharynx. Là, où il y a les végétations anémiques, ils augmentent de taille chez l'enfant. Chez le grand-enfant, ils vont régresser jusqu'à parfois disparaître, ou bien garder uniquement des handicaps.

(55:30 - 55:56)

Donc il ne faut pas les confondre lorsqu'ils sont augmentés de taille avec une tumeur. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'aspect bourgeonnant, d'aspect saignant, d'aspect qu'il va retentir sur par exemple, le prénom de la démorphosie agressif-endastatique ou bien l'extension de l'animal, en l'absence de ces agressivités, on ne pourra pas parler de tumeur. D'autant plus que le cancer du gamin, ça ne bouge pas le petit enfant.

(55:57 - 56:11)

En général, chez 10 ans, 12, 13, 14, 15. Les végétations anémiques sont hypertrophiées chez les nourissants. C'est à partir de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans.

(56:12 - 56:22)

Au-delà, en général, ça diminue de volume. Donc c'est le premier diagnostic qu'il faudra éliminer. Deuxième chose, c'est les tumeurs pénibles.

(56:22 - 56:40)

Par exemple, si c'est du fibromyalgia parvégien, les tumeurs pénibles, ça veut dire qu'ils ne sont pas agressifs, même s'ils sont agressifs parfois, tels que du fibromyalgia parvégien, mais c'est une évolution qui est très longue. En général, ça ne repartit pas sur l'audition. C'est rare que ça reprenne l'audition.

(56:41 - 56:51)

Il n'y a pas de démorphosie qui s'en présente. En général, vous avez une muqueuse qui rencontre un tumeur qui est normal. Une muqueuse qui est lisse.

(56:51 - 57:12)

Remarquez ici, sur la photo que je vous ai mis, est-ce que la muqueuse ici est saine ? La muqueuse ici, elle est irrégulière. Donc, ce qu'on appelle une tumeur congelante. Vous avez des courgents qui sortent à travers la tumeur.

(57:12 - 57:18)

On appelle ça une tumeur congelante. Dans les tumeurs bénis, la muqueuse reste lisse. Ça ressemble à ça.

(57:19 - 57:33)

C'est une muqueuse qui est lisse. Si vous avez une flession du bout du capot avec une muqueuse qui est lisse, ça peut être un cancer, mais c'est un cancer qui est de l'autre nation. Ce n'est pas le carcinome qui le différencie.

(57:35 - 57:55)

Ou bien, si vous avez une muqueuse lisse avec un bonbon, ça correspond souvent à des tumeurs bénis. Les tumeurs bénis, en général, ça entraîne une atteinte muqueuse, avec une muqueuse qui est irrégulière, qui est pulsérée, qui est saignante. Un enfant, une tumeur close du capot, vous pouvez toujours y penser.

(57:55 - 58:31)

Mais souvent, c'est associé à d'autres sites, pulmonaire, l'RING, ou bien les autres cancers que vous avez maintenant, vous avez le carcinome, qui vont avoir le masque, c'est-à-dire une atteinte muqueuse, bourgeonnante, pulsérée, ou bien filtrante. Alors, la classification de ces cancers, pour les T1, c'est le tumeur limité, pour les T2, c'est le tumeur qui va s'étendre latéralement, des

espaces par crâne, GU, piscule, ptéorégulière, c'est-à-dire il y a juste un masticateur, ou bien en arrière. Mais lorsque la tumeur atteint l'os, c'est un stade trop long.

(58:31 - 58:51)

Parce que vous avez une atteinte pulseuse, soit au niveau des sinus, soit au niveau de la base du crâne, c'est un T3. Lorsqu'il y a une extension intracrânienne, c'est un T4. Sur le plan non-gliomère, donc, vous avez le carcinome N1, ils sont unilatéral, moins de 6 cm.

(58:52 - 59:05)

Lorsqu'ils sont bilatéral, c'est le N2. Et toujours, ils sont haut, c'est-à-dire au-dessus du bord inférieur du cartilage. Lorsqu'ils dépassent 6 cm, ou bien lorsqu'ils descendent au niveau du tracé patriculaire, c'est un N3.

(59:05 - 59:22)

Donc là, ça permet de mettre un gradin. La présence de métastases à distance, éparqués, est plus longue. À la fin, on peut placer le malade, par exemple, T3, T2, T1, pour pouvoir discuter par rapport au traitement, pour pouvoir faire les études et suivre le patient.

(59:23 - 59:57)

Alors, comment on étudie par rapport au traitement ? Donc, on a notre patient, le diagnostic, il est confirmé, c'est un carcinome du cavoire, par exemple, un grand enfant, un adolescent, par exemple, de 15 ans, ou bien un adulte de 50 ans, il a un cancer, par exemple, on a une idée sur l'extension ventulaire, sur l'extension au niveau de la base du crâne, maintenant, est-ce qu'on va lui proposer une chirurgie ? Non, pas de chirurgie. Cancer du carin, pas de chirurgie. La chirurgie, parfois, de façon très peu fréquente, après la réduction des thérapies, et surtout au niveau des ganglions, pas au niveau du rhinopharynx.

(59:57 - 1:00:18)

Pour certains, chirurgicalement, un cancer du rhinopharynx. Donc, ça se base sur la radiothérapie, c'est la chimiothérapie, en général, T1, T2, c'est la radiothérapie, T3, T4, c'est la radiothérapie, la chimiothérapie. Il faut savoir que, heureusement, le CNT, il est radiosensif, il est chiriosensif.

(1:00:18 - 1:00:43)

Donc, le patient, lorsqu'il est diagnostiqué, par exemple, un T1, T2, même si le tumor est profond, il a de fortes chances de s'en sortir. Donc, que le tumor, il est indifférencié, plus il répond à la radiothérapie. Plus il est différencié, ça veut dire qu'il ressemble à la cellule humaine, plus il est résistant à la radiothérapie.

(1:00:43 - 1:00:55)

Pourquoi ? Parce que des tumeurs indifférenciées, ils ont un ingest méthodique qui est élevé. La croissance est rapide, les divisions des cellules se font rapides. Donc, la tumeur a besoin d'oxygène.

(1:00:55 - 1:01:54)

Donc, ce qui fait que la radiothérapie, comme vous le savez, ça agit sur la rupture de la molécule d'eau et ça va entraîner la présence de ce qu'on appelle le H₂O₂, c'est l'eau oxygénée qui est agressive pour les tumeurs. Alors, la radiothérapie va se faire sur la tumeur, c'est-à-dire au niveau de l'infarince, en prenant des marches vers la base du crâne, latéralement vers l'épaule supratemporale, on va sur l'infarince, sur la radiothérapie sur la tumeur et sur les aires omblionaires. De toute façon, c'est systématique.

On ne va pas attendre parce que les patients vont avoir plein de réponses qu'il faut faire la radiothérapie. Pourquoi ? Parce que c'est une tumeur qu'on va modifier très lentement. C'est-à-dire que même si le patient est N-0, c'est-à-dire cliniquement qu'il n'y a pas de bénéfices, c'est très probablement qu'il y a déjà une métastase qui sort intra-clinique.

(1:01:55 - 1:02:19)

Les ganglions sont touchés, mais la croissance tumorale n'a pas encore atteint un certain stade pour montrer qu'il y a déjà une émancipation. Dans la chimiothérapie, T3 et T4 sont mis en état de métastase. Et la chirurgie, en général, c'est après la radiothérapie, on présente de l'oligarque omblionaire avec une infarince qui est stérile.

(1:02:19 - 1:02:50)

Là, on peut faire un curage de l'omblionaire, c'est-à-dire qu'on met ici l'eau intra-directorie pour enlever la fatigue résiduelle. Alors, notre pronostic, remarquez ici, ça dépend du cycle histologique, comme on l'a dit, plus le patient a un UCNT, c'est-à-dire indifférencié, plus il a de la chance de s'en sortir. Plus il a le carcinome qui est indifférencié, là le patient il répond moins à la radiothérapie, en plus il n'y a pas de chirurgie qui peut se faire.

(1:02:51 - 1:03:10)

Pendant les stades 1 et 2, on peut avoir un CV qui peut aller jusqu'à 90%. C'est très important. Si le patient a un cancer dans les espaces profonds de la face, sur la base du crâne, et qu'on arrive à guérir, ça c'est une bonne chose, il suffit que le diagnostic soit fait dans les deux premiers stades.

(1:03:10 - 1:03:29)

Alors, sinon dans les stades 3 et 4, avec l'extension qui touche l'os, parce que plus la tumeur touche l'os, moins il répond à la radiothérapie. C'est comme dans le cancer du larynx. Si la tumeur franchit le cartilage laryngeal, il répond moins à la radiothérapie.

(1:03:30 - 1:03:52)

Donc, vous vous rappelez, on a dit qu'il n'y a pas de protocole de conservation d'organes lorsqu'on a une extension franche au niveau du cartilage laryngeal. Même chose ici. S'il y a une atteinte franche au niveau de la base du crâne, au niveau de l'os, la radiothérapie reste efficace à partir de 60 ans, moins par rapport à une tumeur qui siège toujours, qui est confinée au niveau du crâne à base.

(1:03:53 - 1:04:48)

Donc, l'endoscopie, la surveillance doit être prolongée. Il faut surveiller les patients pendant plus de 5 ans parce qu'ils peuvent faire des récurrences après. Donc, la surveillance des cercles endoscopiques, à chaque fois, à chaque contrôle qui se fait entre les uns et les autres, et à chaque fois qu'il y a des sites cliniques de récurrence, ou parfois même un épaississement qui peut apparaître au niveau du rhinoparax, il faudra faire des biopsies.

Ou bien, si on assure le scanner et l'IRM des images encoûtées douteuses, là, l'ORF doit faire des crédits, des biopsies avec études en appartenance. Voilà, donc ça, c'est concernant le conserve du crâne. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la fin ? On prend plusieurs.

On prend les deux types de fréquences. On peut l'avoir chez l'enfant, le grand-enfant et chez l'adulte. Alors, les facteurs de croissance ici, il n'y a pas de tabac, il n'y a pas d'alcool.

(1:04:49 - 1:05:16)

Donc, il ne faut pas attendre à avoir un patient tabagiste, etc. C'est les phénomènes de virus. Les 4 syndromes il faut reconnaître, d'accord ? C'est l'embryonnaire, l'attente ontologique qui sont les plus fréquentes, d'accord ? C'est surtout les autistes cérémiques et les adénopathies syndicales hautes qui sont les signes d'appel pour lesquels le patient ne peut pas aller chez l'enfant.

(1:05:16 - 1:05:33)

il faut avoir une dose de chrétopéracité qui est la dose de chrétopéracité. Donc, il faut avoir, Autre chose, il faut avoir une dose de chrétopératie pour pouvoir aller chez l'enfant. qui est la forme de la maladie.

(1:05:33 - 1:05:34)

Le pire, c'est qu'il y a des

